



სამედიცინო სერვისების ხარისხი

რეზიუმე

სტატიაში განხილულია სერვისების სფეროში არსებული მომსახურების კვლევის სამედიცინო და ტერმინოლოგიური პრობლემები და ჯანდაცვის ორგანიზაციებში მომსახურების შეფასების ძირითად საკითხები. სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კატეგორიებისადმი სისტემატური მიდგომის საფუძველზე სტატიაში შესწავლილია პაციენტის სერვისით დაკმაყოფილება, ნაჩვენებია სამომხმარებლო მოლოდინის როლი მომსახურების აღიარებული ხარისხის შეფასებისას და ნაჩვენებია, რომ სამედიცინო დაწესებულებებში სერვისის სათანადოდ არ არის შესწავლილი და შეფასებული.

კვლევის საფუძველზე ავტორები აღწერენ სამედიცინო მომსახურების ორგანიზაციების მომხმარებელთა ქცევას, შეიმუშავენ რა სამომხმარებლო ქცევის მოდელს, რომელიც განსხვავდება არსებულთაგან. ავტორები ასკვნიან, რომ ეკონომიკური კომპონენტის გარდა, საკომუნიკაციო კომპონენტებთან ერთად, ჯანდაცვის სერვისების საავტორო მოდელის დანერგვა გვიჩვენებს სამედიცინო ორგანიზაციების მომხმარებლების ქცევის სახასიათო ნიშნებს. სტატიაში ხაზგასმულია ჯანდაცვის სერვისების მომხმარებელთა სუბიექტური გადაწყვეტილების ფაქტორები, რომლებიც შეფასებულია ხარისხის აღსაწერად.

საკვანძო სიტყვები: სამედიცინო სერვისი, მომსახურების ხარისხი, მომხმარებლის კმაყოფილების გრძნობა

სოციალურ-კულტურულ სფეროში მომსახურების ხარისხისადმი ყურადღება განპირობებულია სახელმწიფო დონეზე მიღებული იმ გადაწყვეტილებებით, რომლებიც დაკავშირებულია სახელმწიფო სერვისების გაუმჯობესებასთან.

ჯანდაცვის სახელმწიფო სისტემის რეფორმირების ფონზე სულ უფრო მეტ აქტუალობას იძენს სამედიცინო სერვისების ხარისხის ზრდა, რომელზედაცაა სწორედ აქცენტირებული რეფორმები.

სამედიცინო სერვისის ხარისხის ამაღლების ამოცანები მოითხოვს სამეცნიერო და მეთოდურ დასაბუთებას, ვინაიდან ამ პრობლემებისადმი მიძღვნილი პუბლიკაციების ანალიზმა გვიჩვენა ერთიანი მიდგომის არარსებობა. არ-

ლელა კოჭლამაზაშვილი

ეკონომიკის დოქტორი,

სტუ-ს პროფესორი

ელენე ჩარკვიანი

სტუ-ს დოქტორანტი

E-mail: mariamkvirikashvili770@gmail.com

სებული მოდგომები მეტწილად ორიენტირებულია სამედიცინო ორგანიზაციების მიერ შეთავაზებული უმთავრესი მომსახურების, - მკურნალობის, - საექსპრტო შეფასებაზე. [1] ამდენად, სამედიცინო მომსახურების მომხმარებლები გამოირიცხებიან სუბიექტების იმ სიიდან, რომელთაც აქვთ სამედიცინო მომსახურების ხარისხზე ზეგავლენა და, აქედან გამომდინარე, მომხმარებლებისათვის მნიშვნელოვანი სერვის-მომსახურება რჩება სამედიცინო მომსახურების პერიფერიაზე.

ხარისხი, როგორც სისტემური კატეგორია, წარმოადგენს ურთიერთდაკავშირებული ელემენტების კომპლექსს, რომლის შინაარსი ვლინდება გარემოსთან ურთიერთკავშირის პროცესში. ამდენად, თვით ხარისხიც, როგორც მომსახურების მახასიათებელი, მომსახურების პროცესში ვლინდება. [3] გამომდინარე აქედან, ხარისხის შეფასებისათვის საბაზისო მაჩვენებლად გვევლინება მომხმარებლის დაკმაყოფილების დონე.

მომხმარებელთა კმაყოფილება წარმოადგენს მომხმარებელთა მიერ მათი მოთხოვნილებების შესრულების ხარისხის აღქმას, სადაც აღქმა მომხმარებლების სუბიექტური შეფასებაა, ხოლო მოთხოვნილება კი - მოლოდინი, რომელიც დადგენილია, მოსალოდნელი და, აქედან გამომდინარე, სავალდებულო. თუ მომსახურების მოსალოდნელი ხარისხი ჭარბობს ხარისხს, მომხმარებელი კმაყოფილია, წინააღმდეგ შემთხვევაში - არა.

მომსახურების ხარისხით მომხმარებლის დაკმაყოფილების გაზომვა დაკავშირებულია ერთგვარ სიძნელეებთან. ეს არის ხარისხის განუსაზღვრელობაც, მისი დამოკიდებულებაც მომხმარებელზე, მისი შეფასების სუბიექტურობაზე. მომსახურების ხარისხის მეკვლევის ამოცანაა - შეისწავლოს ზემოქმედების ფაქტორები მომხმარებლის თვალსაზრისით.

სამედიცინო მომსახურების დონისადმი მომხმარებელს შეიძლება გააჩნდეს შედარებით დაბალი მოთხოვნები. პაციენტი (იგივე მომხ-



მარეგული) ყოველთვის არ გვევლინება მომსახურების ფასის გადამხდელად. მაგალითად, იმ შემთხვევაში, როცა საყოველთაო დაზღვევის პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებებით სარგებლობს, რასაც ბიუჯეტი ანაზღაურებს. მომხმარებელთა ქვეშევსებაში საბიუჯეტო დაფინანსება გაიგივებული უფასოსთან, ეს სტერეოტიპი კი ზეგავლენას ახდენს მათ მოლოდინებზე და ადაბლებს მათი მოლოდინების დონეს.

როგორც საავტორო კვლევების შედეგებმა უჩვენა, საბიუჯეტო გადახდის შემთხვევაში მომხმარებელი ყოველთვის სრული მასშტაბით არ ავლენს საკუთარ მოთხოვნილებებს და სამომხმარებლო აქტივობას.

ყველაზე მეტად სამომხმარებლო აქტივობას აიგივებენ სამომხმარებლოსთან, რომელსაც გააჩნია ისეთი მახასიათებლები, როგორიცაა სიხშირე და ნაყიდის საერთო ღირებულება. მაგრამ სოციალურ-კულტურული სფეროს ორგანიზაციებისათვის სამომხმარებლო აქტივობა, ჩვენი აზრით, უნდა განიხილებოდეს, როგორც ინტეგრირებული კატეგორია, რომელიც მოიცავს არა მხოლოდ საყიდლების, არამედ მომსახურების მწარმოებელთან ურთიერთკავშირის მახასიათებლებსაც. სოციალურ-კულტურული სფეროს მომხმარებლების კვლევამ გვიჩვენა, რომ დიდი მნიშვნელობა გააჩნია მომხმარებელთა

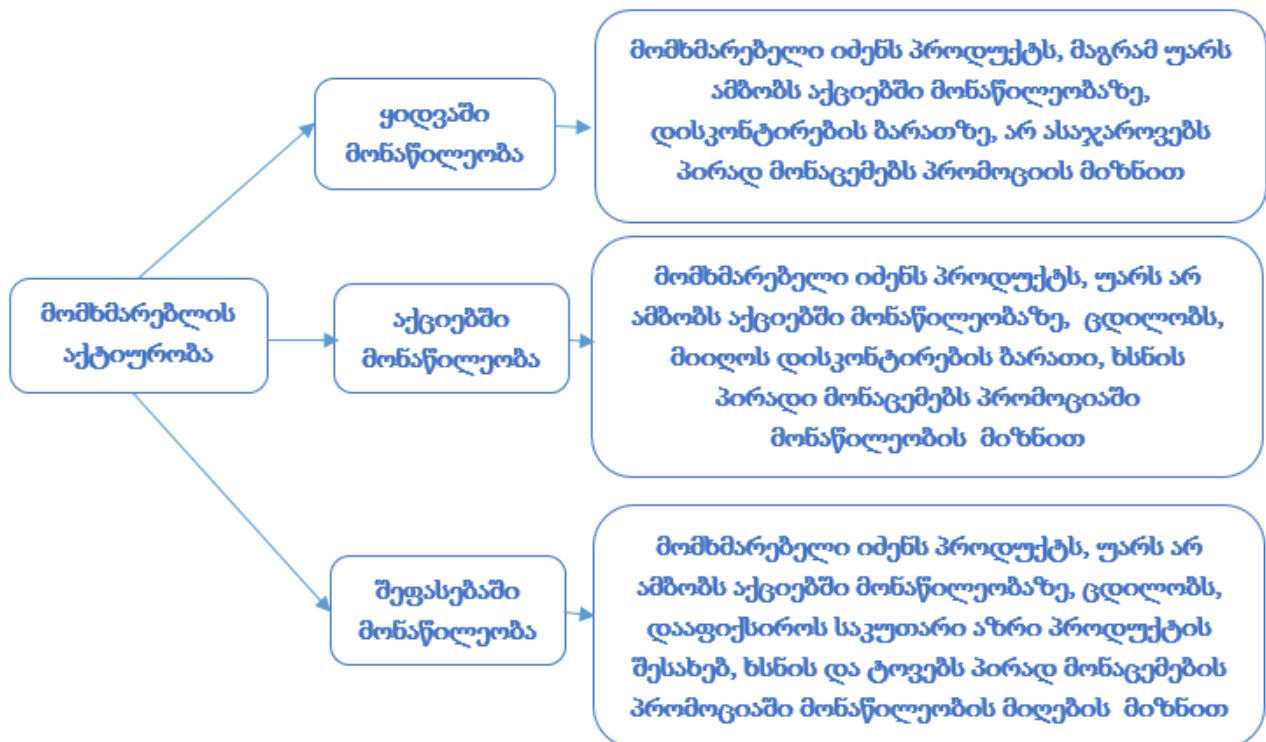
აქტივობის ისეთ კომპონენტებს, როგორც პრომო აქციებში და გამოკითხვებში მონაწილეობა, რომლებიც წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს საინფორმაციო არხს მომსახურების ხარისხზე ინფორმაციის შემოღინებისათვის (დიაგრამა 1).

კვლევა მიმდინარეობდა ანკეტირების ფორმით. კვლევისას სურვილი იყო, გამოკითხულიყო ყველა პაციენტი, მაგრამ თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა მხოლოდ მათ 23,8%-მა. ჩვენ გამოვაგლინეთ იმ მიზეზების რეიტინგი, რომლის გამოც პაციენტებმა უარი განაცხადეს ანკეტირებაზე:

1. პასუხის გაცემას აზრი ირ აქვს, ვინაიდან ეს მაინც არაფერს შეცვლის - 30%,
2. ცუდად ვგრძნობ თავს - 30%,
3. ჩამოყალიბებული აზრი არ გამაჩნია - 20%,
4. პასუხს არ გაგცემთ, პერსონალის დამოკიდებულება ჩემს მიმართ შეიცვლება - 10%,
5. გულგრილობა - 10%.

ნათელია, რომ სამომხმარებლო აქტიურობის დონე არ არის მაღალი და ამას როგორც ობიექტური, ასევე სუბიექტური მიზეზები გააჩნია. ისინი სუბიექტურნი არიან ხარისხის შეფასებისას, ვინაიდან მათი მდგომარეობა არაერთგვაროვანია. მათ აერთიანებს მხოლოდ ერთი რამ - ისინი ვერ გრძობენ თავს უსაფრთხოდ, რაც აძლიერებს მათი შეფასებების სუბიექტურ-

დიაგრამა 1. სოციალური აპტიურობის მოდელი





დიაგრამა 1. სოციალური აქტიურობის მოდელი

პასუხის ვარიანტები	%	სულ, +/-
არის wi-fi	11	
კარგია, ნორმალურია, არც ისე ცუდია და სხვა	15	
სისუფთავეა, რემონტია, კარგი პირობებია	24	
კარგი კვებაა	7	
კარგი, გამოცდილი, კვალიფიცირებული პერსონალია	15	+81%
განმკურნეს, გადამარჩინეს, მეორედ დავიბადე	9	
ცუდი მატერიალური პირობებია	9	
პერსონალის მხრიდან ცუდი დამოკიდებულებაა	5,5	
იმაზე უარესია, ვიდრე ლაპარაკობენ, უარესია, ვიდრე ვფიქრობდი	4,5	

ობას, რაც გულისხმობს მომხმარებლის შემეცნების თვისებას, მომსახურების ხარისხის კომპონენტებად აღიქვას ისიც, რომელსაც არავითარი კავშირი არ გააჩნია მომსახურების მწარმოებელთან.

მომხმარებლის შეფასების სუბიექტურობა და სერვისული მომსახურებისადმი არსებულმა დაბალმა მოლოდინებმა ერთობლიობაში გაეღვნა იქონია სამედიცინო მომსახურების ხარისხის აღქმაზე.

ცხრილში 1 წარმოდგენილია პასუხების რაოდენობის გადანაწილება იმ კითხვებზე, რომლებიც აპრიორი არ შეიცავს შეფასებებს. რესპონდენტების 21%-მა გამოთქვა აზრი და აქედან 80%-მა დადებითი შეფასება მისცა სერვისების ხარისხს, ხოლო 19%-მა კი უარყოფითი.

რესპონდენტების მიერ დამოუკიდებლად ჩამოყალიბებული პასუხის ვარიანტები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიმსჯელოთ მათ დაბალ მოლოდინებზე, ანუ ნორმალური მდგომარეობა მომხმარებელთა მიერ აღქმულია, რაგარც ზღვარს გადამცდარი და არაორდინარული.

საინტერესოა, რომ ისეთი ფაქტორი, როგორიცაა სოციალური გარემოცვა, მომხმარებლებმა შეაფასეს, როგორც მომსახურების თვისება, თუმცა იგი ასეთს არ წარმოადგენს. ანუ, სამედიცინო მომსახურების მომხმარებელი შეიძლება

არ იყოს კმაყოფილი საკუთარი გარემოცვით (მაგალითად, საკუთარი თანაპალატელებით) და იგი თავის უკმაყოფილების გრძნობას გადაიტანს და მიაწერს სერვისის დაბალ ხარისხს.

სამედიცინო მომსახურების ქვეშ რესპონდენტები გულისხმობენ პერსონალის საქმიანობას, რომელიც მიმართულია მომხმარებლის მიზნის შესრულებაზე, ანუ მკურნალობაზე. სამედიცინო სერვისის კი პაციენტები აიგივებენ სამკურნალო ორგანიზაციის მიერ იმ ხელსაყრელი პირობების შექმნასთან, რომელიც კომპორტულს ხდის სამედიცინო მომსახურებით სარგებლობას.

ამრიგად, სამედიცინო მომსახურების ხარისხი წარმოადგენს ინტეგრირებულ კატეგორიას, რომელიც აერთიანებს სამედიცინო სერვისისა და სამედიცინო მომსახურების შედეგებს. [2]

სერვისული მომსახურება არის სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი, რომელიც ამაღლებს სამედიცინო გარემოცვის ხარისხს. პუბლიკაციებისა და საკუთარი კვლევის შედეგების ანალიზმა აჩვენა, რომ ფასიან კერძო სამედიცინო ორგანიზაციებში ხარისხის აღქმა არის გაცილებით მაღალი, ეს კი გვიძლიერებს მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ სამედიცინო მომსახურების შეფასებისას აუცილებელია დიფერენცირებული მიდგომა.



გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Andrews, S. L. QA vs QI: The Changing Role of Quality in Health Care. // J. Quality Assurance. - 1991. - Vol. 38. - P. 14-15.
2. Banks, N. J. Variability in clinical systems: applying modern Quality control methods to health care. / [N. J. Banks, R. H. Palmer, D. M. Berwick et al.] // Jt. Comm. J. Qual. Improv. - 2005. - Vol. 21. - P. 407-419.
3. Batalden P., Buchanan E. Industrial models of quality improvement. In: Goldfield N., Nash D., eds. Providing quality care: the challenge to clinicians // Philadelphia: American College of Physicians. 1989. - P. 133-155.
4. Batalden P.B., Nelson E.C., Roberts J.S. Linking Outcomes Measurement to Continual Improvement: The serial "V" Way of Thinking about improving Clinical Care // Journal on quality improvement, 1994, - Vol. 20, 4. - P.167-180.
5. Crombie I. K., Irving L., Elliott L., Wallace H. Closing the Health Inequalities Gap: An International Perspective. // WHO Regional Office for Europe. Copenhagen. 2005. - p. 81.
6. Dahlgren G, Whitehead M. Policies and strategies to promote equity in health. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 1992 [cited 2011 Feb 10]. Available from: [http://whqlibdoc.who.int/euro/-1993/EUR_ICP_RPD414\(2\).pdf](http://whqlibdoc.who.int/euro/-1993/EUR_ICP_RPD414(2).pdf)
7. Donabedian A. "The Quality of Care: How Can It Be Assessed?" JAMA260 (1988): 1743-48.

THE QUALITY OF MEDICAL SERVICES

LELA KOCHLAMAZASHVILI

Doctor of Economics,

Professor of GTU

ELENE CHARKVIANI

The Doctoral Student of GTU

Summary

The article defines the scientific and terminological problems of researching services in the field of services, the basic problems of the evaluation of services in health care organizations. On the basis of a systematic approach to the category of quality of medical services, the article investigates patient satisfaction with the perceived quality of service, shows the role of consumer expectations in the evaluation of the perceived quality of services and finds that the requirements for the service in medical institutions are underestimated.

On the basis of studies the author identifies behaviors of consumers of medical services organizations, develops a model of consumer activities, which differs from the existing ones that along with the economic component the model is complemented with communication components. The approbation of the author's model for health care services shows a characteristic pattern of consumer activity of medical organizations. The article highlights the factors of subjective judgment of health care consumers in assessing perceived quality.

Keywords: medical services, service quality, customer satisfaction with the quality of health services